一页流程 | 斜视诊疗指南

判断条件与下一步 · 按本篇原文整理 · 2026

1 病史、眼位、视力与屈光

全面眼检查 / 双眼视；儿童睫状肌麻痹验光；急性 / 非共同或外伤 → 先病因与必要神经 / 眶影像。

2026 PDF1–3 、 7–8 、 11 、 13–14 、 19–20

2 先屈光与弱视处理

足矫及弱视治疗后，重新测量远近角和控制 / 立体视，再按内 / 外 / 特殊分支决策。

2026 PDF3–7

3 内斜分支

全矫正位→调节性；残余 >10△→ 部分调节性评估手术；高 AC/A>6:1→ 双焦点等；先天按年龄时机。

2026 PDF4–7

4 外斜分支

控制良好→观察；频率 / 评分恶化或立体视下降→考虑手术；恒定 / 先天按对应时机。

2026 PDF9–10

5 麻痹 / 特殊分支

病因治疗；一般角度稳定约 6 月再手术；眶嵌顿 / 肌断裂等可早介入；各综合征见专门条目。

2026 PDF7 、 11–19

6 围术期与长期复查

按 2026 术前方案；术后第 1 天、第 1 周、第 1 、 3 、 6 个月，此后每 6 ～ 12 个月；术后异常受限 + 复视及时排滑脱。

2026 PDF7–8 、 19–21

流程为整理表达；原文未明确的切点、剂量或等级不补编。完整证据与特殊分支见提取表。